

# Codziennie — *nie raz w tygodniu*

Sesja w gabinecie to 1h tygodniowo. ERP musi „mieszkać” w codzienności — to **NAJSILNIEJSZY** predyktor wyniku terapii.

**CZAS:** 30-60 min dziennie 4-5 razy w tygodniu — minimum

**ŹRÓDŁO:** Simpson i wsp. (2011); Foa i wsp. (2005); Abramowitz i wsp., *Treatments That Work*

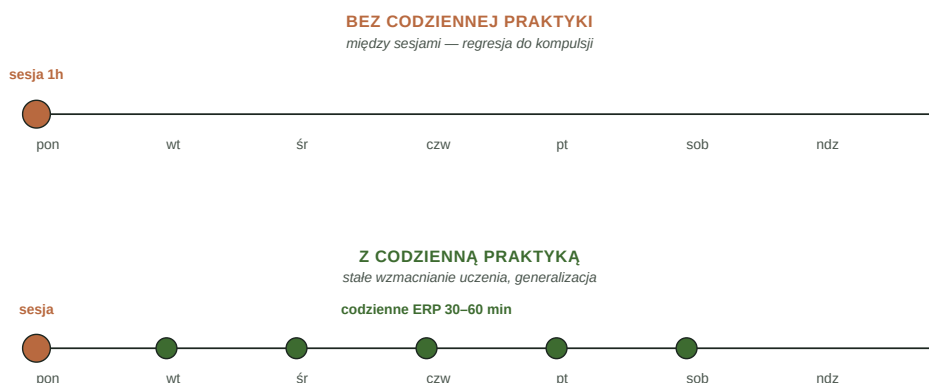
## JAK UŻYWAĆ

Ustal **stałą porę dnia** (np. 17:00-18:00). Wybierz 1-3 ekspozycje z *hierarchii*. Wykonuj protokół: **PRZED** — prognoza + SUDS. **WYKONAJ** — 20-30 min z powstrzymaniem reakcji. **PO** — wynik + SUDS, porównaj z prognozą. Prowadź *dziennik ERP*. Przeglądaj co tydzień z terapeutą.

## DLACZEGO TO DZIAŁA

Simpson i wsp. (2011, badanie 87 pacjentów): pacjenci wykonujący **≥ 80% ekspozycji domowych** mieli 2× *większą poprawę* niż pacjenci niewdrażający ERP w codzienność. **Przestrzeganie zaleceń** (ang. *adherence*) jest **najsilniejszym** predyktorem wyniku — silniejszym niż liczba sesji z terapeutą, niż początkowa ciężkość, niż wiek diagnozy. Foa i wsp. (2005): intensywny program ERP (2 godziny dziennie przez 3-4 tygodnie) osiągnął **86% wskaźnik odpowiedzi** — najwyższy w literaturze OCD. Mechanizm: więcej naruszeń oczekiwań → silniejsze uczenie inhibicyjne (*model hamowania*) + generalizacja kontekstów + budowanie sprawczości.

## 01 Dlaczego sama sesja nie wystarczy



## 02 Protokół sesji domowej — 5 kroków

- 1 Stała pora dnia.** Np. 17:00-18:00. Mózg ADHD lubi rutynę. *Bez dyscypliny czasowej ERP umiera w pierwszym tygodniu.*
- 2 Wybierz 1-3 ekspozycje** z hierarchii — z aktualnego poziomu trudności (SUDS 30-60 w tym tygodniu).
- 3 PRZED** — zapisz: prognoza („co się stanie?”), SUDS początkowy. **Bez tego punktu** uczenie nie ma odniesienia.
- 4 WYKONAJ** — minimum 20-30 min ekspozycji. *Bez kompulsji*, w tym **mentalnych**. SUDS co 5 min. Toleruj dyskomfort.

## 03 Dziennik ERP — tygodniowy

| DZIEŃ | EKSPOZYCJA | SUDS<br><i>przed → po</i> | KOMP.<br><i>T / N</i> | CZEGO SIĘ NAUCZYŁEM/-AM |
|-------|------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Pon   |            |                           |                       |                         |
| Wt    |            |                           |                       |                         |
| Śr    |            |                           |                       |                         |
| Czw   |            |                           |                       |                         |
| Pt    |            |                           |                       |                         |
| Sob   |            |                           |                       |                         |
| Ndz   |            |                           |                       |                         |

## 04 Mniejsze pytania, większa praktyka

### „NIE CZUJĘ SIĘ GOTOWY/-A”

**Gotowość nie poprzedza działania** — rośnie z niego (ACT). „Nie czuję się gotowy/-a / robię to” — formuła. Czekanie na gotowość = czekanie na nigdy.

### „NIE MAM CZASU”

**30 min ERP** dziennie zwraca się 10×: mniej kompulsji oszczędza godziny. Spójrz na dziennik — ile czasu już idzie na OCD?

### „WCZORAJ NIE ZROBIŁEM/-AM”

Brak winy. **Wracaj dzisiaj**. Przestrzeganie  $\geq 80\%$  to 5–6 dni z 7. Jeden pominięty dzień *nie psuje* terapii — pominięty tydzień psuje.

### „ROBIĘ EKSPOZYCJE, NIE POMAGA”

**Sprawdź**: czy wykonujesz kompulsje mentalne podczas ekspozycji? Czy szukasz zapewnienia po? Czy używasz bodźców bezpieczeństwa? Najczęściej tu leży problem.

**Klucz**: Simpson i wsp. (2011): „*adherence to homework is the single strongest predictor of treatment outcome in OCD*”. Foa i wsp. (2005): intensywne ERP (2 godziny dziennie przez 3–4 tygodnie) — odpowiedź 86%. Krótki schemat (1 sesja tygodniowo bez praktyki domowej) — odpowiedź 40–50%. Liczy się **codzienna praktyka**, nie ilość sesji z terapeutą. ERP musi *mieszkać w codzienności*. Stała pora, dziennik, cotygodniowy przegląd. **To inwestycja kilku miesięcy** — w zamian życie wolne od OCD. Bilans korzystny.